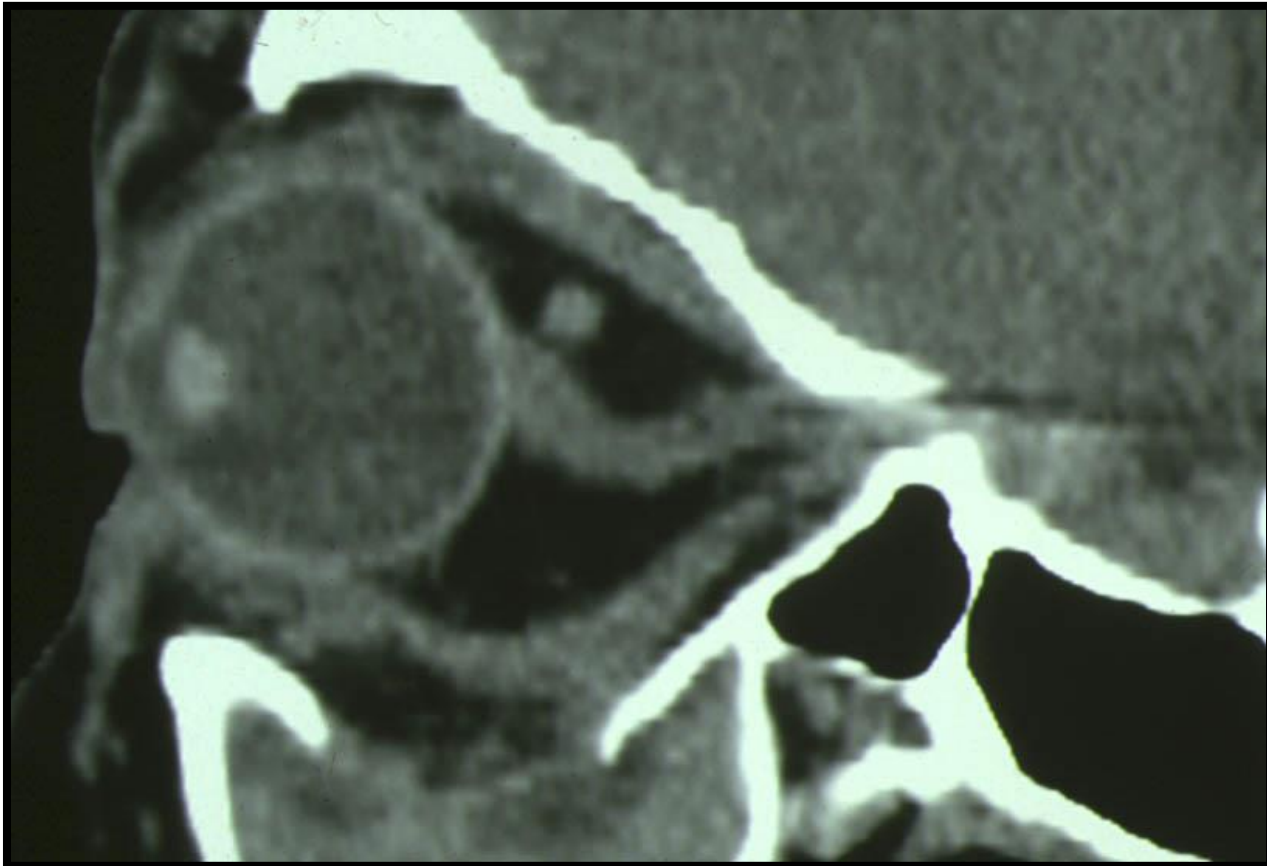
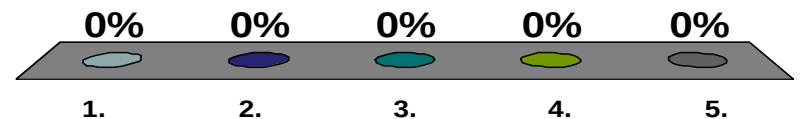
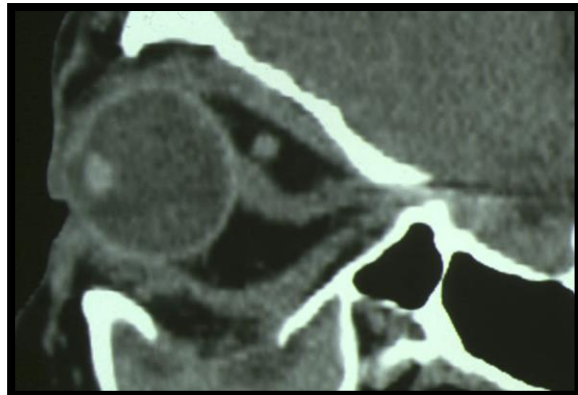


Un jeune homme de 23 ans consulte pour un traumatisme orbitaire droit. Le scanner du massif facial montre une fracture du plancher orbitaire



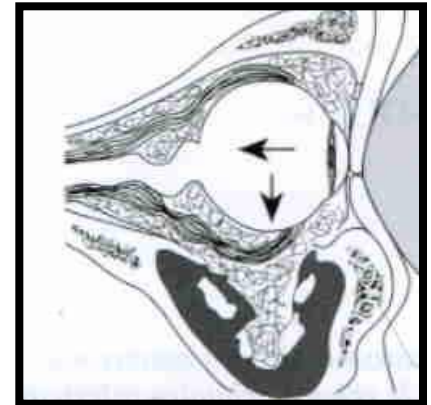
Quel signe clinique entraine une indication opératoire ?

1. Douleur orbitaire
2. Crépitation sous-cutanée
3. Hémorragie sous-conjonctivale
4. Hypoesthésie du V2
5. Diplopie dans le regard primaire



Diplopie

- Les 2 indications opératoires sont la diplopie persistante (raison fonctionnelle) et l'énophtalmie (pour des raisons esthétiques).
- La crépitation sous-cutanée à la palpation (ou emphysème sous-cutané) est le signe d'une fracture orbitaire mais n'oriente pas sur sa localisation.
- L'hypoesthésie du V2 n'oriente pas dans tous les cas vers une fracture. Elle peut être le témoin d'une contusion ou d'un hématome de la région du nerf infra-orbitaire
- Quant à l'hémorragie sous-conjonctivale, elle est totalement aspécifique

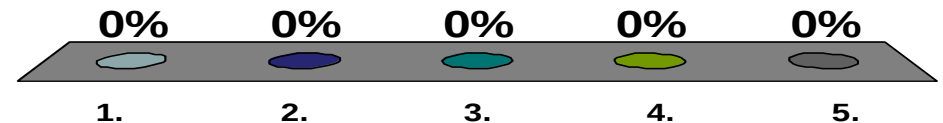


Un judoka de 51 ans vous consulte en raison d'un ptosis palpébral droit apparu il y a deux jours. Il a aussi remarqué que ses pupilles sont de diamètre inégal. Il vous fait remarquer qu'il souffre aussi de douleurs sourdes non pulsatiles de la mâchoire et de la tempe du côté droit depuis 4 jours. Votre examen montre un ptosis droit de 2mm, ainsi qu'une anisocorie à l'obscurité (les pupilles mesurent 2.5 mm en lumière forte, mais 3.5mm à droite et 6mm à gauche dans l'obscurité). Sa vision, son oculomotilité et l'examen du fond sont normaux.



Quelle est votre attitude face à ce patient?

1. Examen neurologique en urgence
2. Imagerie du sinus caverneux
3. Imagerie des carotides
4. Imagerie du tronc cérébral
5. Dosage d'anticorps spécifiques et test au Tensilon (édrophonium)



Syndrome de Horner douloureux

- Ptosis palpébral acquis
 - Mécanique
 - Myasthénie
 - Neurologique
 - Fibres parasympathiques III (releveur palpébral)
 - Fibres sympathiques (muscle de Müller)
- Anisocorie
 - Essentielle, physiologique
 - Mécanique (traumatisme, opérations, uvéites)
 - Pharmacologique (collyres, patch cutané, plantes)
 - Neurologique
 - Fibres parasympathiques
 - Fibres sympathiques
- Syndrome de Horner douloureux
 - Dissection carotidienne
 - Urgence dans les premiers 15 (30) jours : risque d'AVC !
 - Anticoagulation



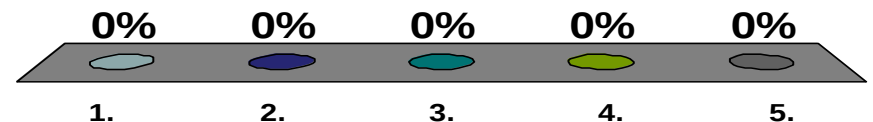
Obscurité

Imagerie des carotides

Un homme âgé de 66 ans vous consulte à cause d'une baisse de vue progressive de l'œil droit depuis 1 semaine sans douleurs associées. Il a eu une opération de cataracte à l'œil droit il y a 5 mois. Il a présenté quelques phosphènes il y a 10 jours. Initialement, la perte visuelle était inférieure et a gagné progressivement tout son champ visuel.

Quelle est l'origine la plus probable de la baisse de vue?

1. Œdème maculaire cystoïde
2. Occlusion de la veine centrale
3. Décollement de rétine rhégmatoïde
4. Artérite temporale (Maladie de Horton)
5. Hémorragie vitréenne



Take home message

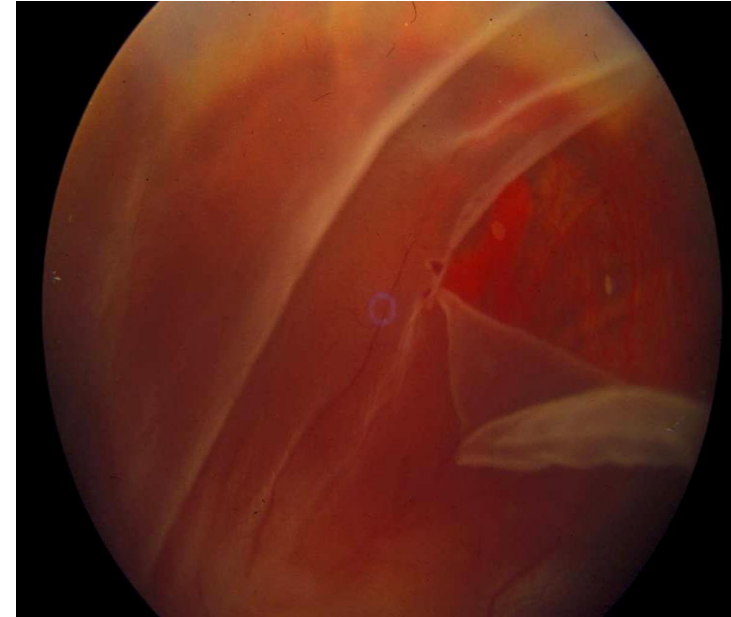
Décollement de rétine rhégmato-gène

a) Phosphènes

b) Baisse d'acuité et de champ visuel

L'opération de la cataracte augmente le risque de faire un décollement de rétine dans les semaines/mois qui suivent l'opération

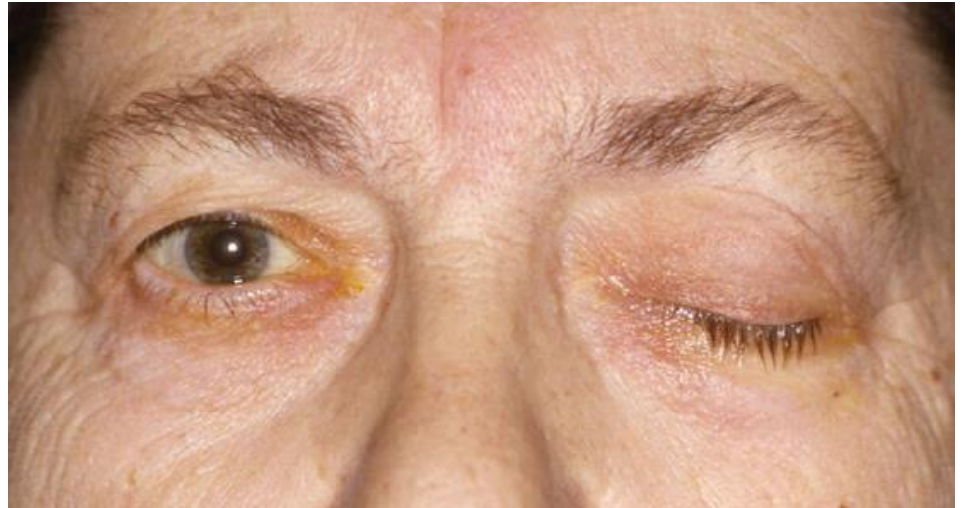
Le décollement de rétine doit être opéré soit par une vitrectomie et injection de gaz ou bien par la mise en place d'une compression épisclérale



Un patient de 80 ans, diabétique et hypertendu, s'est réveillé ainsi:

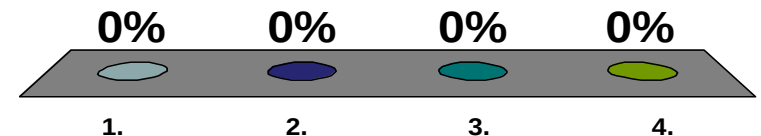
Il mentionne des céphalées inhabituelles depuis quelques jours.

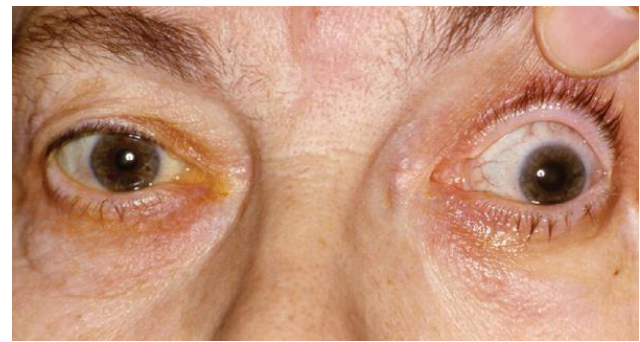
En soulevant sa paupière, en lumière vive :



Quelle affirmation est **correcte**?

1. Paupière relevée, pas de diplopie
2. Etiologie microangiopathique, pas d'investigation urgente
3. Opération strabologique dans les 6 mois
4. La pupille anormale est la gauche

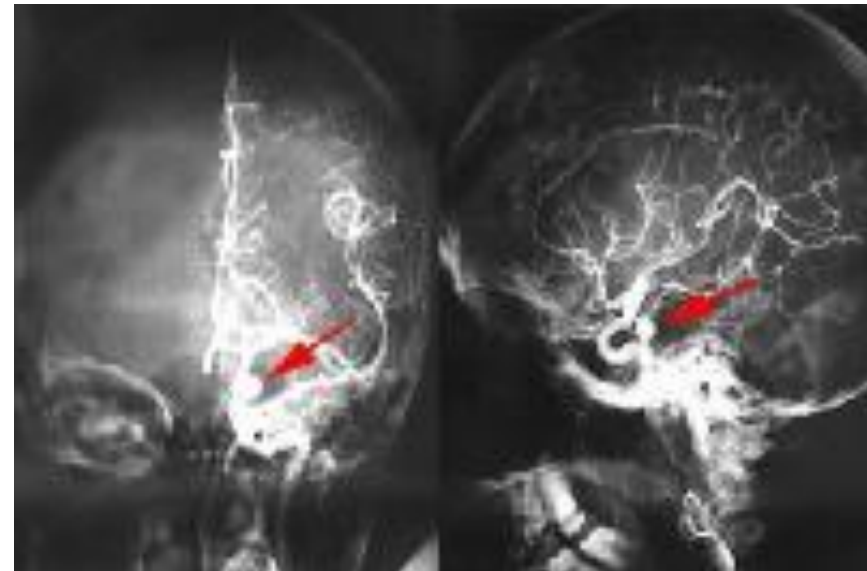




- La pupille anormale est la gauche
 - L'anisocorie augmente à la lumière = la pupille en mydriase est anormale
 - L'anisocorie augmente dans l'obscurité = la pupille en miosis est anormale

- Parésie du III douloureuse

- Patient <55 ans
 - Compressif (anévrisme)
- Patient > 60 ans
 - Vasculite (maladie de Horton)
 - Microangiopathique
 - Compressif (anévrisme)

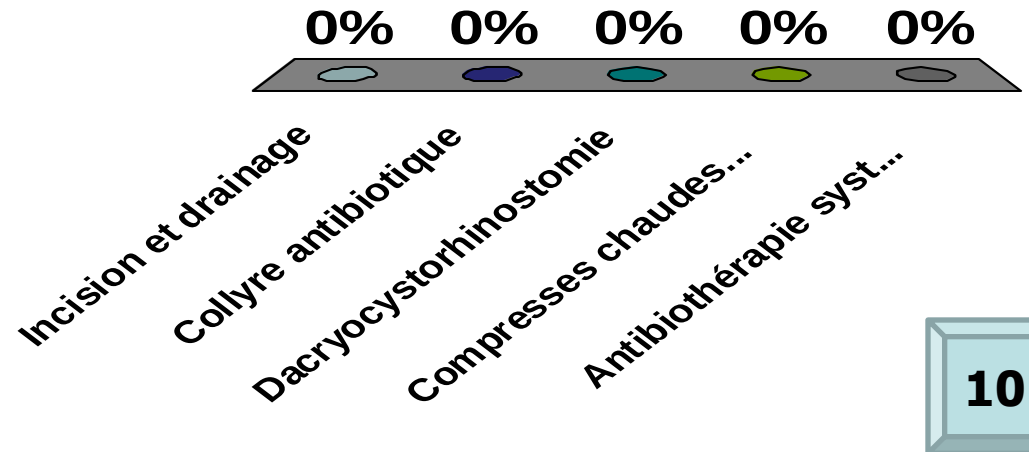


Une jeune patiente de 7 ans consulte pour une tuméfaction douloureuse du canthus interne.



Quel est le traitement le plus approprié ?

- A. Incision et drainage
- B. Collyre antibiotique
- C. Dacryocystorhinostomie
- D. Compresses chaudes de thé noir
- E. Antibiothérapie systémique



Antibiothérapie systémique

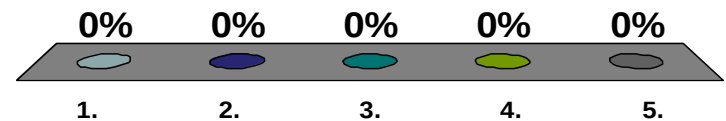


- La dacryocystite aiguë est une inflammation d'origine infectieuse du sac lacrymal, situé en regard du canthus interne et sous le tendon canthal interne.
- Elle est secondaire à une obstruction du canal lacrymonasal.
- Le traitement consiste en une antibiothérapie puis une dacryocystorhinostomie
- Elle peut se compliquer d'abcédation et évoluer vers la cellulite orbitaire.
- Risque d'infection/thrombose du sinus caverneux (veine angulaire)

Un homme de 45 ans, fumeur (20 cigarettes/jour), représentant en commerce de vins, consulte pour changer ses lunettes. Il se plaint de voir de moins en moins bien depuis 6 mois. Son acuité visuelle est de 10/10 difficile des deux côtés et l'examen du champ visuel par confrontation montre un déficit du côté temporal de chaque œil.

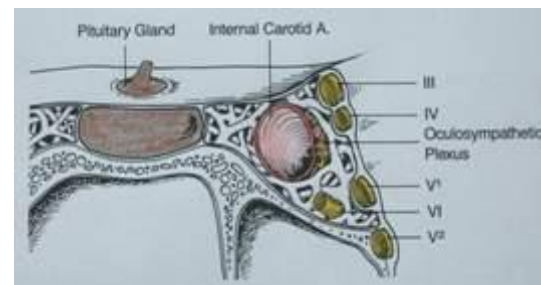
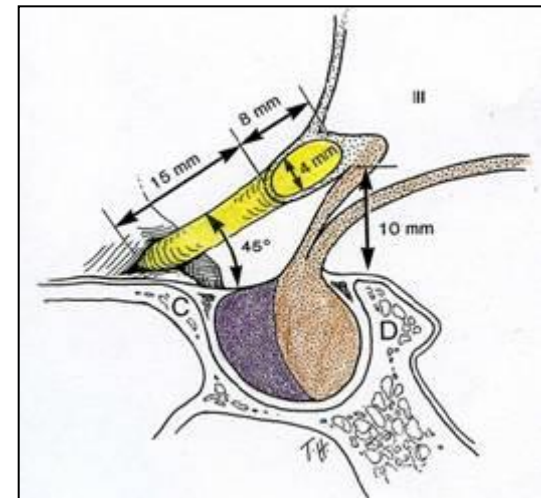
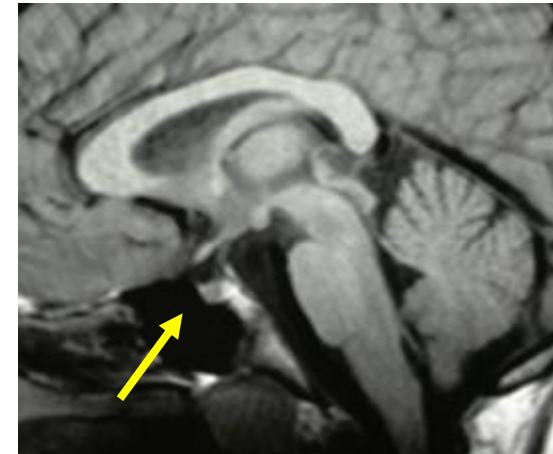
Quelle est la cause la plus probable de son problème ?

1. Neuropathie optique toxico-carentielle
2. Rétinopathie bilatérale
3. Carcinomatose méningée
4. Macroadénome hypophysaire non sécrétant
5. Métastase rétrochiasmatique droite

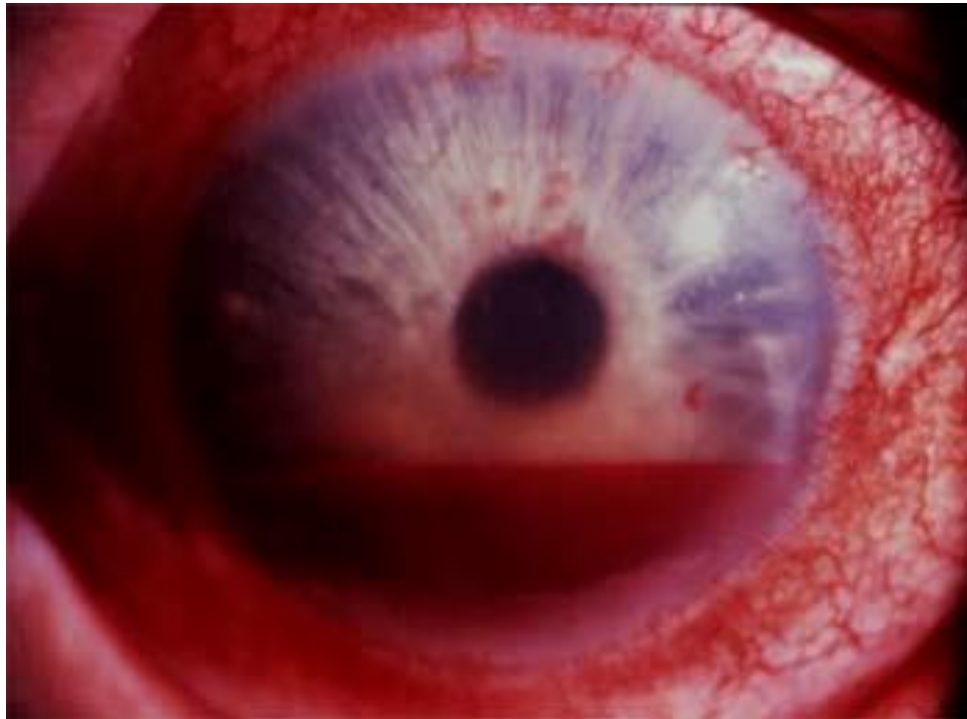


Macroadénome hypophysaire

- Déficit bitemporal
 - Très localisateur → chiasma optique
 - Dysfonction des fibres qui décussent
 - Rétine nasale
 - Acuité visuelle conservée (initialement)
- Adénome hypophysaire
 - Syndrome chiasmatique
 - Neuropathie optique
 - Hémianopsie homonyme
 - Bandelettes optiques
 - Parésie oculomotrice
 - Sinus caverneux

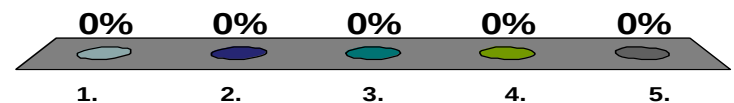


Une dame âgée de 76 ans vous consulte en urgence à cause d'un œil gauche douloureux depuis 1 semaine. Elle est connue pour une hypertension artérielle et elle a été examinée par un ophtalmologue il y a 6 mois pour une « thrombose » dans l'œil gauche. Elle n'a plus consulté depuis. Les douleurs sont en train d'augmenter depuis quelques jours et elles irradient vers l'oreille gauche.



Quelle est l'origine la plus probable des douleurs ?

1. Rétinopathie diabétique proliférative
2. Glaucome néovasculaire
3. Iridocyclite
4. Neuropathie optique antérieure ischémique
5. Sclérite postérieure



Glaucome néovasculaire



Secondaire à occlusion ischémique veineuse rétinienne (OVCR, OBVR)

Sans prise en charge adéquate une OVCR/OBVR ischémique peut, par une augmentation de VEGF, conduire à une prolifération de vaisseaux dans l'angle iridocornéen associé à un glaucome.

Une pression intraoculaire très élevée peut conduire à des très fortes douleurs (distribution du nerf trijumeau)

Le pronostic d'un glaucome néovasculaire est réservé

Enfant de 13 mois, bsh.

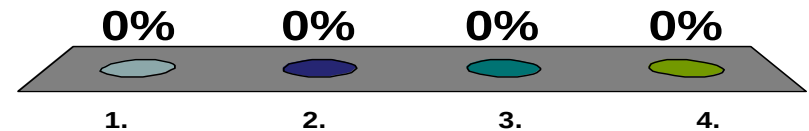
Les parents consultent pour une position anormale des yeux .

Un mois après chute en avant (premiers pas)



Quelle attitude est la plus adéquate?

1. Suivi ophtalmo 4 sem.
2. Imagerie cérébrale
3. Intervention chirurgicale dans les 6-12 mois
4. Rassurance des parents: strabisme convergent congénital

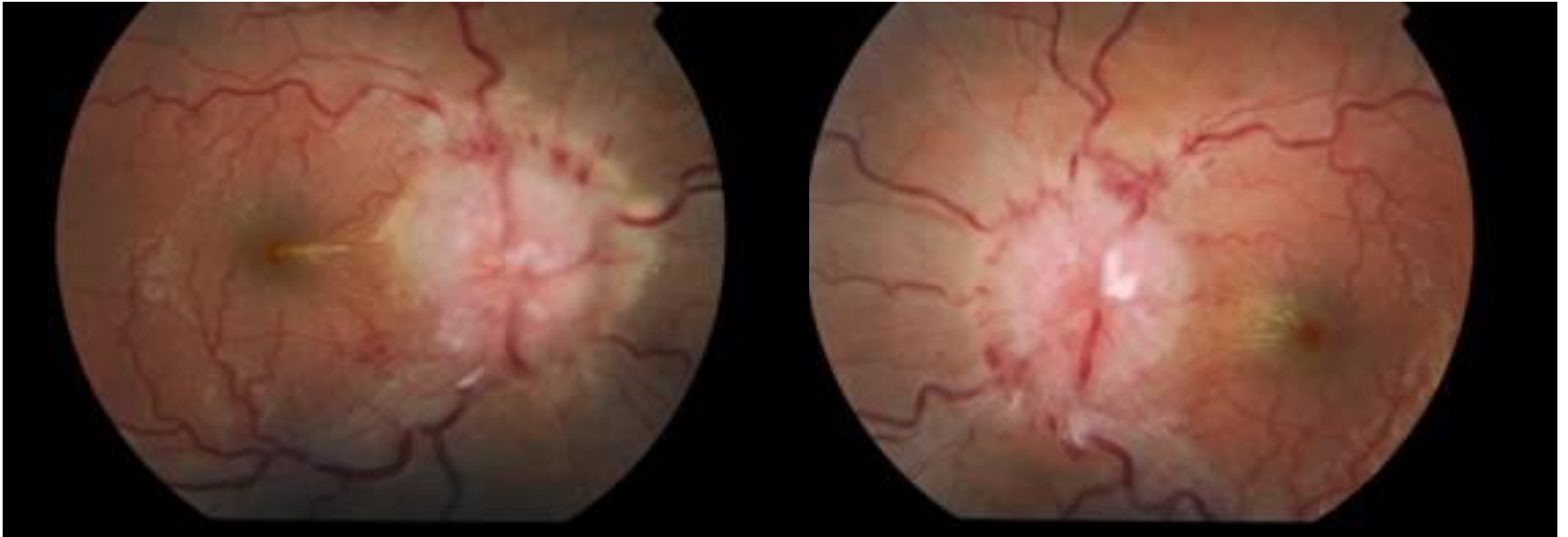


Imagerie cérébrale en urgence



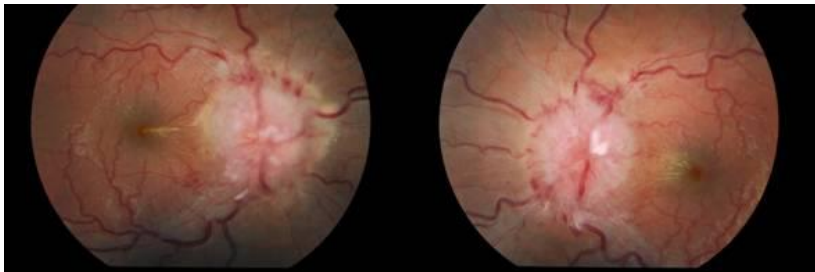
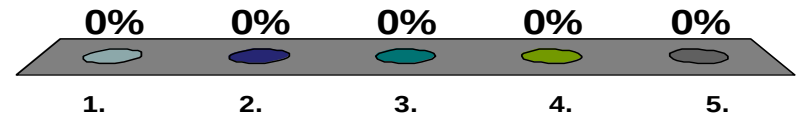
- une parésie du VI qui survient 1 mois après un traumatisme mineur ne peut pas être attribuée à ce traumatisme; il faut exclure une compression du VI par une **tumeur**
- Devant tout strabisme convergent, il convient d'**exclure une parésie du VI** (examen de l'oculomotilité)
- L'apparition d'un strabisme avant la fin de la maturation du système visuel (période critique, 7-8 ans) peut provoquer une **amblyopie** de l'œil non fixateur
- Une parésie du VI peut être liée au déplacement vers le bas du tronc avec élongation du VI , secondaire à une **hypertension intra-crânienne**. Un **œdème papillaire** bilatéral peut alors être présent

Une femme de 26 ans, obèse (95kg, 162 cm), consulte pour des épisodes de flou visuel transitoire depuis 3 semaines, surtout lors des changements de position. Son acuité visuelle est normale, son champ visuel par confrontation est entier, et l'examen du fond d'œil est le suivant:



Lequel de ces examens vous permettra d'orienter au mieux la prise en charge?

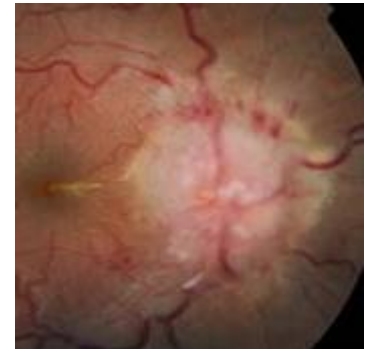
1. Examen neurologique
2. Angiographie fluorescéinique
3. CT cérébral avec injection de produit de contraste
4. IRM cérébrale avec Gadolinium
5. Ponction lombaire



Œdème papillaire de stase - HTIC

IRM cérébrale avec Gadolinium

- HTIC → stase de matériel axoplasmique papillaire
 - Obscurations visuelles transitoires
 - Acouphènes pulsatiles
 - Diplopie horizontale (parésie du VI)
 - Perte visuelle rare
 - Maculopathie, occlusion vasculaire, ischémie du nerf optique, neuropathie optique progressive atrophique, membrane néovasculaire
- Etiologies HTIC
 - Effet de masse (tumeur, hématome, kyste)
 - Thrombose (sinus cérébral veineux, veine jugulaire)
 - Inflammation/infection (méningite, encéphalite)
 - Toxique/médicament (Vitamine A, tétracyclines,...)
 - Résorption LCR (Tu. queue de cheval - hyperprotéinorachie, cellules tu.)
 - Hypertension intracrânienne idiopathique (ex- pseudotumor cerebri)

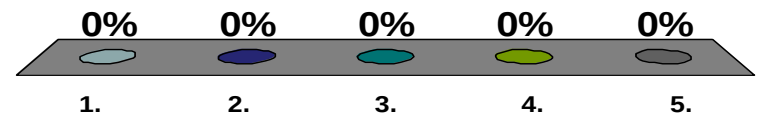


!! Pas de PL avant IRM !!

Une jeune fille de 19 ans a reçu une canne de hockey dans son œil droit vers 10h du matin. Elle se présente aux urgences vers 12h. L'œil est gonflé est fait mal. La patiente n'a pas perdu connaissance lors du coup. L'acuité visuelle est réduite à « compter les doigts ».

Quel est l'examen le plus simple dans cette situation pour exclure une rupture du globe oculaire ?

1. Ophtalmoscopie indirecte à la lampe à fente avec lentille +90 D
2. Ultrason 10Hz et 20Hz
3. Examen à la lampe à fente et prise de la pression intraoculaire
4. Champ visuel informatisé
5. Electrorétinogramme



Take home message

Examen de l'œil à la lampe à fente et prise de la pression intraoculaire

Les signes d'une rupture du globe oculaire sont:

- a) Chemosis de la conjunctive
- b) Pression intraoculaire effondrée ~ 0 mm Hg

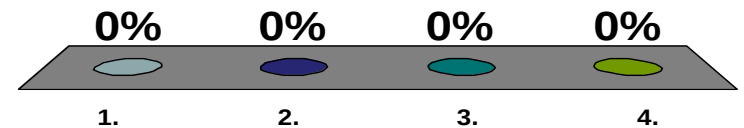
Attention exception: Une très petite rupture (par exemple perforation par corps étranger métallique) peut être autoétanche sans chémosis et avec une pression intraoculaire normale

Fillette de 6 ans, bsh.
Position anormale
des yeux depuis
toujours.



Quelle attitude n'est pas appropriée ?

1. Examen oculomoteur
2. Mesure de l'acuité visuelle des 2 yeux
3. Examen du fond d'œil
4. Opération strabologique à l'adolescence



Opération strabologique à l'adolescence



- L'examen des **reflets cornéens** (test de Hirschberg) permet le **diagnostic d'un strabisme**, et une quantification grossière de l'angle.
- Toujours **exclure une parésie du VI** devant un strabisme convergent
- Ce strabisme, présent de longue date, est probablement accompagné d'une **amblyopie sévère de l'œil dévié**, si l'œil dévié est toujours le même.
- Un strabisme peut avoir une **origine organique** (cataracte, pathologie rétinienne ou du nerf optique) qu'il convient d'exclure.